EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 84654
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 17-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DIEGO ENRIQUE GUZMAN BADILLA			RUN	: 19.487.313-1
F.Nac	: 29-05-1997	Edad	: 26 AÑOS, 11 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: LOS NOTROS 1020 11 DE SEPT.			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 414379		
Fecha Ingreso	: 2024-05-14	Fecha Egreso	: 17-05-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G35.X-ESCLEROSIS MULTIPLES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) ITU en tratamiento
2) Esclerosis multiple
3) Influenza A (+)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta en SU HSC el 14/05 por caudro de 5 dias de evolucion de fiebre, disuria, polaquiuria, mialgia genralizada, cefalea, aumento de debilidad de EEII. Examenes de lab al ingreso con PCR 89,6; uremia 21; BUN 10; Na/K/Cl 135/4.1/100; GB 11,6; segment 85%; orina de aspecto turbio, nitritos (+), 500 leu/uL, bacterias regular cantidad, INfluenza A positivo.
Se decide ingreso para terapia ATB y rehabilitacion
Durante estadia con peaks febriles intermintes, pero con mejoria de sensibilidad y capacidad motora.

Paciente HDN estable, registra peak febril de 38,1°C a las 16:30 hrs, refiere buen dormir, sin episodios de nauseas y/o vómitos, con buena tolerancia a alimentación VO, diuresis y deposiciones (+). Sin nuevos episodios de debilidad de tren inferior
Examenes de lab 17/05 -> crea 0,8; LDH 147; lactato 0,7; PCR 62,4; uremia 18; Na/K/Cl 145/4.8/106; Hb/Hcto 14.4/42.2; Gb 4; plaq 218000; segment 63%
TAC TAP 16/05 -> Dentro de límites normales
Ex físico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP
Ex neurológico fuerza y sensibilidad conservada en las cuatro extremidades

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con disminución de parámetros inflamatorios, exámenes imagenologicos sin hallazgos sugerentes de sepsis, se cultimara terapia ATB por 7 dias, se realizara seguimiento de caso via HODOm, se solicitara control con parámetros inflamatorios para dia lunes 20/05

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo relativo 30°
2. 2. Regimen liviano a tolerancia
3. 3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 3 dias (para completar 7 dias de terapia)
4. 4. Omeprazol 20 mg al dia VO por 3 dias
5. 5. Oseltamivir 75 mg c/!2 hrs VO por 1 dias (completar 5 dias de terapia)
6. 6. Sertralina 50 mg al dia VO
7. 7. Amantadina 100 mg al dia VO
8. 8. Dimetilfumarato 240 mg c/12 hrs VO
9. 9. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO por 3dias
10. 10. Metamizol 300 mg c/!2 hrs VO por 3 dias
11. 11. Bromuro de ipratropio 2 puff c/8hrs por AC por 3 dias
12. 12. Examenes de control 20/05
13. 13. KNT motora dos veces al dia

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO